

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD & YOUNG (ER-25)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Resiliencia y Recursos de Recuperación

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER-25 / RS-25).
Nombre Original (Inglés)	<i>The Resilience Scale (RS-25)</i>
Autoras Originales	Dras. Gail M. Wagnild y Heather M. Young (1993), The Resilience Center.
Adaptaciones al Español	Novella (2002, Perú); Sánchez-Teruel & Robles-Bello (2015, España); Ruiz et al.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Resiliencia, Factores Protectores y Adaptación Positiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico dimensional de 25 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Población comunitaria y clínica ambulatoria.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Propiedad intelectual registrada de The Resilience Center; uso clínico y de investigación autorizado bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO PENTAFATORIAL DE WAGNILD & YOUNG

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) es el estándar internacional más consolidado para la cuantificación de la **resiliencia disposicional**. Las autoras conceptualizan la resiliencia como una capacidad psíquica nuclear y modificable que capacita a la persona para moderar el impacto desestructurante del estrés agudo o crónico y prosperar constructivamente ante la adversidad vital.

El modelo teórico original postula 5 dimensiones o pilares esenciales del funcionamiento resiliente:

1. **Ecuanimidad:** Perspectiva vital serena y equilibrada; capacidad de modular los extremos emocionales y conservar el sentido del humor.
2. **Perseverancia:** Determinación inquebrantable de seguir adelante y mantener el esfuerzo proactivo a pesar de los reveses.
3. **Confianza en uno mismo:** Creencia firme en las capacidades y habilidades individuales para solventar contingencias imprevistas.
4. **Satisfacción personal:** Convicción íntima de que la propia existencia tiene propósito, significado y contribución valiosa.
5. **Soledad existencial:** Aceptación madura y serena de la propia individualidad y autonomía, reconociendo que cada persona es única.

A nivel macrofactorial, estas características se agrupan en dos grandes factores: **Competencia Personal** (17 reactivos vinculados al control y autoeficacia) y **Aceptación de Uno Mismo y de la Vida** (8 reactivos de adaptabilidad existencial). Neurobiológicamente, se asocia a una mayor densidad de receptores cannabinoides y plasticidad hipocámpica, unida a una rápida desactivación simpática mediada por tono vagal parasimpático alto.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE FACTORES DE ÍTEMS

Componente Resiliente	Ítems (25)	Nº Ítems	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Confianza en uno mismo	3, 5, 9, 17, 18, 23, 24	7 ítems	Autonomía percibida, seguridad resolutive y sentido de autoeficacia interna.
2. Perseverancia	1, 2, 10, 13, 14, 20	6 ítems	Persistencia y disciplina conductual orientada a metas pese a la fatiga o el dolor.
3. Ecuanimidad	7, 8, 11, 12	4 ítems	Perspectiva templada de los acontecimientos; capacidad de relativizar y humor.
4. Satisfacción personal	6, 15, 21	3 ítems	Convicción de sentido biográfico, satisfacción con la vida y orgullo constructivo.
5. Soledad existencial	4, 16, 19, 22, 25	5 ítems	Aceptación de la individualidad, tolerancia a la no aprobación y flexibilidad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión métrica: alfa de Cronbach global de 0.88 a 0.93 en adaptaciones españolas e hispanoamericanas (Novella, 2002; Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2015). Fiabilidad test-retest $r = 0.84$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica tanto la solución jerárquica de dos factores de segundo orden (Competencia Personal y Aceptación de la Vida; CFI = 0.92, RMSEA = 0.055) como la validez del factor general único de resiliencia disposicional.
Validez Concurrente y Convergente	Fuertes correlaciones directas con satisfacción con la vida (SWLS, $r = 0.58$), autoeficacia percibida ($r = 0.62$), afecto positivo (PANAS-P, $r = 0.54$) y autoestima ($r = 0.57$). Correlaciones inversas muy robustas con depresión (BDI-II, $r = -0.52$), ansiedad rasgo (STAI, $r = -0.49$) y distrés somático.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Sensibilidad demostrada en intervenciones de psicoterapia basada en fortalezas, logoterapia y programas de resiliencia comunitaria, registrando incrementos significativos (d de Cohen = 0.75 a 1.05) tras el entrenamiento.
Invarianza Demográfica	Invarianza de medida ratificada a través de sexos y cohortes etarias; se observa un incremento normativo moderado y progresivo de la resiliencia global con la edad y madurez biográfica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 25 reactivos se califica en escala Likert de 7 puntos (**1** = «Totalmente en desacuerdo», **2** = «En desacuerdo», **3** = «Ligeramente en desacuerdo», **4** = «Neutral / Indeciso», **5** = «Ligeramente de acuerdo», **6** = «De acuerdo», **7** = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene ítems invertidos; todas las afirmaciones están redactadas en sentido afirmativo resiliente.
- **Paso 2 (Puntuación Total ER-25):** Suma aritmética de las puntuaciones asignadas a los 25 reactivos: $\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{25} \text{Ítem}_i$.
- **Rango Teórico Global: 25 a 175 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de resiliencia disposicional y capacidad de recuperación.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (WAGNILD & YOUNG, 1993)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Resiliencia	Conducta Asistencial Recomendada
Muy Baja	25 a 114 puntos	Vulnerabilidad severa (corte < 115)	Fragilidad extrema ante crisis; alto riesgo de descompensación depresiva o traumática. TCC prioritaria.
Baja	115 a 124 puntos	Resiliencia baja / Vulnerable	Recursos de afrontamiento frágiles; dificultad para recuperarse de reveses. Foco en autoeficacia.
Moderada-Alta	125 a 144 puntos	Resiliencia adaptativa media	Capacidad de adaptación adecuada en la mayoría de estresores cotidianos; repertorio funcional.
Alta	145 a 160 puntos	Alta resiliencia disposicional	Excelente tolerancia a la adversidad, determinación perseverante y pronta recuperación.
Muy Alta	161 a 175 puntos	Resiliencia óptima / sobresaliente	Gran fortaleza psíquica, capacidad de encontrar sentido al sufrimiento y liderazgo.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO DE VULNERABILIDAD (< 115 PUNTOS):

En pacientes remitidos tras pérdidas biográficas graves o acontecimientos potencialmente traumáticos, una puntuación en la ER-25 **inferior a 115 puntos** constituye un indicador crítico de riesgo de cronificación psicopatológica (Trastorno por Estrés Postraumático o Episodio Depresivo Mayor), exigiendo intervención preventiva inmediata orientada a la reconstrucción del sentido vital y autoeficacia.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DÉFICIT DE RESILIENCIA (TCC / ACT)

PROTOCOLO DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA BASADO EN LA ER-25:

- **Paso 1 (Mapeo de Factores Débiles):** Identificar si la carencia principal radica en **Competencia Personal** (autoeficacia/perseverancia) o en **Aceptación de la Vida** (ecuanimidad/soledad existencial).
- **Paso 2 (Reconstrucción de Autoeficacia):** Si predomina la baja autoconfianza (ítems 3, 5, 17, 23), aplicar revisión de logros biográficos previos (experiencias de dominio) y diseño de metas intermedias alcanzables.
- **Paso 3 (Aceptación Existencial y Sentido):** Si el déficit reside en satisfacción personal (ítems 6, 21), trabajar clarificación de valores nucleares y logoterapia (Viktor Frankl: transformar la tragedia en logro humano).
- **Paso 4 (Monitorización):** Una ganancia de **>= 20 puntos** en la ER-25 al cabo de 12 semanas consolida la autonomía funcional del paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS PÉRDIDA TRAUMÁTICA Y ACCIDENTE

Identificación: Mujer de 35 años, ingeniera civil, derivada tras sufrir un grave accidente de tráfico que conllevó 6 meses de inmovilización y secuelas físicas moderadas. Acude por llanto incontrolado, apatía profunda y convicción de que "mi vida perdió todo valor y propósito". Cumple criterios de Trastorno Adaptativo Severo con síntomas mixtos.

Evaluación Inicial ER-25 (Línea Base): Puntuación Total = **86/175 puntos** (Rango Muy Bajo / Vulnerabilidad Severa). Puntuaciones en ítems de sentido vital y ecuanimidad colapsadas: ítem 21 ("Mi vida tiene sentido") = 1/7; ítem 13 ("Puedo salir de tiempos difíciles") = 2/7; ítem 17 ("Mi confianza me saca adelante") = 2/7.

Plan Terapéutico Aplicado: 14 sesiones de psicoterapia centrada en aceptación, compromiso con valores y entrenamiento en resiliencia. Se reconceptualizó la rehabilitación física no como un castigo sino como un desafío de perseverancia diaria y se reactivaron proyectos de consultoría remota.

Reevaluación a las 14 Semanas: Puntuación Total ER-25 = **142/175 puntos** (+56 pts, acceso al Rango Moderado-Alto / Adaptativo). El ítem 21 ascendió a 6/7 y el ítem 13 a 7/7. La paciente verbalizó: "El accidente cambió mi cuerpo, pero me enseñó una fortaleza interna que no sabía que poseía".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PSEUDORRESILIENCIA / DENEGACIÓN DEFENSIVA:

Puntuaciones máximas (170-175) pueden ocultar a veces una fachada de autosuficiencia omnipotente o represión afectiva (alexitimia / apego evitativo). Contrastar si la aparente fortaleza convive con somatizaciones o desconexión emocional relacional.

RESILIENCIA VS. ESTADO ANÍMICO:

Durante una crisis aguda o shock de duelo, la resiliencia autopercebida puede descender temporalmente sin implicar una vulnerabilidad estructural irreversible. Reevaluar una vez amortiguada la fase aguda del impacto traumático.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.
2. Wagnild, G. (2009). A review of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 17(2), 105-113.
3. Novella, A. (2002). Incremento de la resiliencia luego de la aplicación de un programa psicoterapéutico en adolescentes. *Tesis de Licenciatura*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
4. Sánchez-Teruel, D., & Robles-Bello, M. A. (2015). Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14): Propiedades psicométricas en una muestra española. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 40(2), 103-113.